

NS: 22221836898 / 585

MAURILIO CALVO FILHO	
MEDICAMENTOS:	Glyxambi / Stamet 30 / Crestor / Lipidil / Benerva
SINTOMAS/QUEIXAS	Sedação / Selo 20K / Zyloric / Glyxambi / Stamet
BANHEIRO	Perda progr. da memória recente.
HORA QUE ACORDA	há 1 ano.
HORA QUE DORME	
PRÁTICA EXERCÍCIO	IAH = 44/h
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES	
CAFE: OK	ALMOÇO: OK LANCHE: N JANTA: N lanche
18/10	Início
20/10	Leitura à distância
	P = 11.6 cmH ₂ O
	IAH = 11.5/h (C = 4.3 / IA = 9.0 / IH = 2.5)
	M. de uso: 7hr.
	Fuga = 42 l/min
	flua clíndica
23/11/22	P = 10.3 cmH ₂ O
	IAH = 6.2 e/h
	M. de uso: 5h15'
	Fuga = 56.7 l/min
	Clíndica e sonolência diurna
	Coloquei soneca a tarde
06/12	P = 11.8 cmH ₂ O
22	IAH = 7.3 e/h
	M. de uso: 5h9'
	Fuga = 20.1 l/min.
	flua
22/12	P = 10.8 cmH ₂ O
22	IAH = 6.2 e/h
	M. de uso: 4h55'
	Nem adaptado
	Transferiu cognitivo leve.
13/03	P = 11.0
23	IAH = 7.9
	M. de uso: 451'
	Fuga = 18.4
15/03	P = 10.8
23	IAH = 5.9 e/h
	M. de uso: 5h30', bem adaptado
	relato eausa ao resp.
	flua

17/04
23 $P = 10.8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 8.1 \text{ e/ev}$
m. de uso: 5h23'

Fuga import. de ar

fua.

01/02/25

21/06
23 $P = 10.8 \text{ cmH}_2\text{O}$
m. de uso: 5h26'
 $IAH = 6.0$

Fuga = 4.5 l/min $\rightarrow$ vazamento em alguns dias
fua.

20/07
23 $P = 10.8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 6.1$
m. de uso: 5h35'
Fuga = 33.5

fua.

24/08
23 $P = 10.8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 7.4 \text{ e/ev}$
m. de uso: 5h34'

fua cláudio

30/10
23 $P = 10.8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 4.6 \text{ e/ev}$
m. de uso: ~~5h30'~~
Fuga = ~~5h30'~~ 7.0/perc 95% 48.3

fua.

30/11
23 $P = 10.8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 6.6$
m. de uso: 5h30'
Bem adapt.

fua

11/01
24 $P = 10.8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 6.4 \text{ e/ev}$
m. de uso: 5h26'

fua.

15/02
24 $P = 10.8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 8.1 \text{ e/ev}$
m. de uso: 5h27'
Bem adaptado

fua.

09/08
24 $P = 10.8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 7.0 \text{ e/ev}$
m. de uso: 6h13'

fuga: 17.5 l/m (mediana)

Bem adaptado

Natacha

20/01
25 30d uso + 9d. $\rightarrow$ relata que n consegue dormir
 $P = 10.8 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 2.4 \text{ e/ev}$
m. de uso:

20/02/25 Não utiliza CPAP desde 12/02

Período de 14/03 a 12/02

P=10,8 cmH₂O

IAH=6,4 cmH₂O

mdc uso: 5h58'

fluxo: 7,1 l/m

Orientado a medicação neurológica devido à memória

Relata dificuldade de usar aparelho

Natasha

26/03/25 Usou 15 de 30 dias

não usa desde 12/03

P=10,8 cmH₂O

IAH=5,6 cmH₂O

mdc uso: 6h9'

* Apresenta momentos de confusão

Está fazendo exames de neuro

Natasha

08/05/25 P=10,8 cmH₂O

IAH=8,4 cmH₂O

mdc uso: 6h1'

fluxo: 5,4 l/m

Realizou exames de

neuro e vai passar o médico no dia 22.05

Natasha

Nome: MAURÍLIO CALVO FILHO

Data de Nascimento: 17-6-1946

IMC: 33,95

Sexo: Masculino

Data do exame: 06-08-2021

Peso: 110 kg

Altura: 1,80 m

Medico: DR. MARIO SILVA JORGE

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 06-08-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 479,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 17,0 e 123,0 minutos. O tempo total de sono foi de 312,0, eficiência de 65,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,5%; estágio N2: 61,4%; estágio N3: 16,3%; sono REM: 18,8%. O índice de despertares foi de 20,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 44,0/hora, sendo elas 35 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 146 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e mínima de 84%, permanecendo 5,9% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 43 - 83 bpm e NREM de 40 - 86 bpm.

CONCLUSÃO: *Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (11), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:*

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 44,0/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=84%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco no traçado.

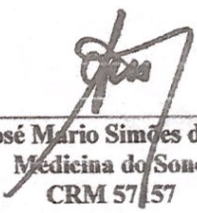
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.57

Mário Silva Jorge

Neurologia – CRM27123
Membro Efetivo da Academia de Neurologia
Membro Titular da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica
Member's of International Headache Society
Doutor em Neurologia Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP)
Médico do Ambulatório de Reabilitação Cognitiva da Disciplina de Neurologia da FMUSP

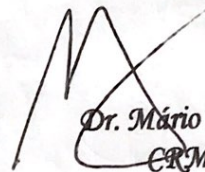
Maurício C. Arko

*em o paulista aceso R/
m de CPAP*

a/Ava Cláudia

m de por.

SJCampos, 7/10/2022



Dr. Mário Silva Jorge
CRM 27.123

Cons.: UNEP – DEPARTAMENTO DE NEUROLOGIA
Rua Cel. José Domingos de Vasconcelos, 400 – V. Adyanna – São José dos Campos
Tel.: (0xx12) 3921-2071 / Telefax: (0xx12) 3921-4177
Eletroencefalograma – Mapeamento Cerebral

*18/10 14h TAMIRIS
R. Santa Elza 418*